

La Splénomégalie

Préparation du concours de résidanat FMM 2025

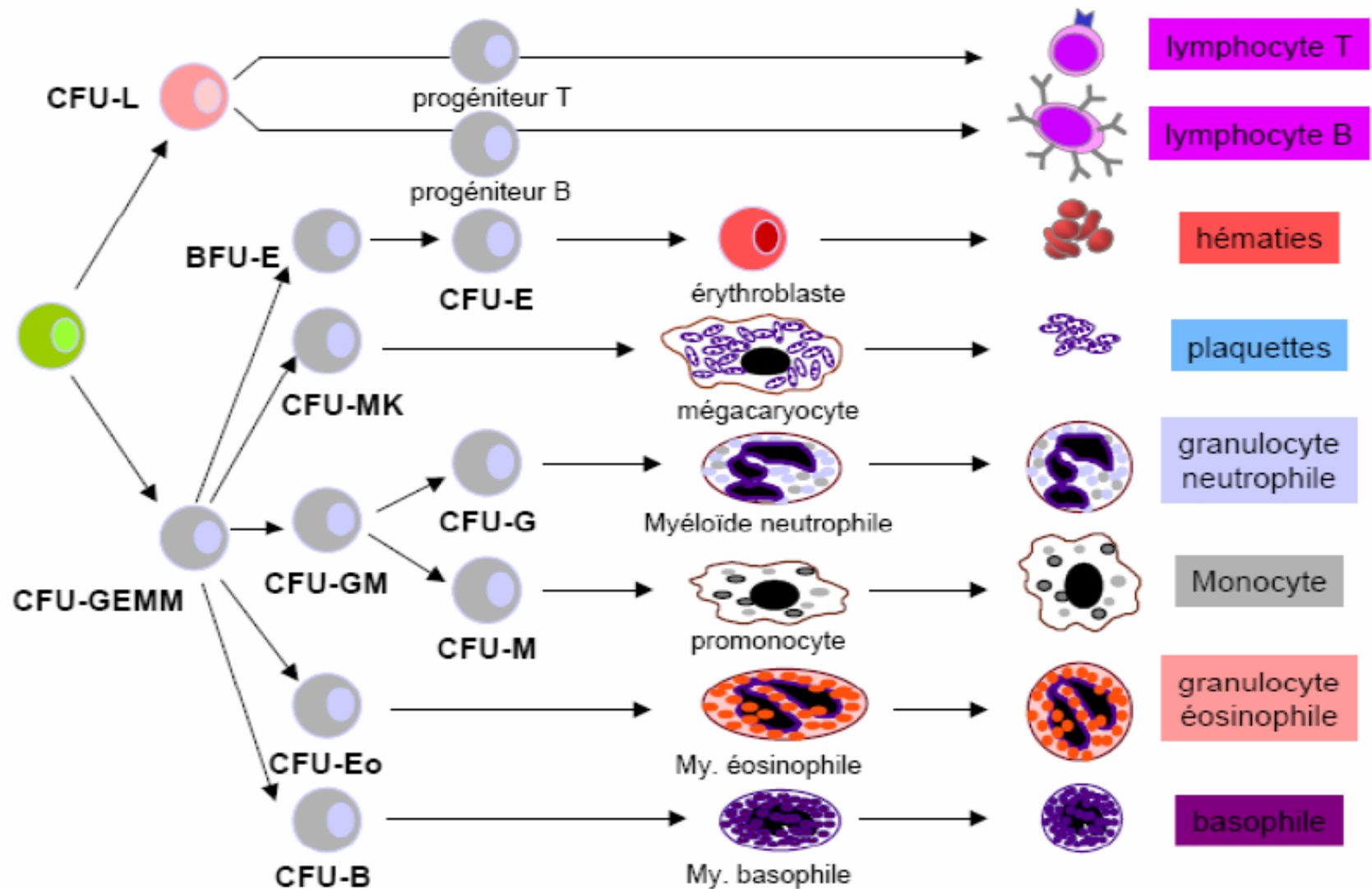
Dr Nader SLAMA

Prof. Ag en Hématologie clinique

CHU Fattouma Bourguiba, Monastir

19/08/2025

Les compartiments de l'hématopoïèse



cellule
souche

PROGENITEURS

PRECURSEURS

cellules matures

Observation N°1

- Enfant de 6 ans
- Syndrome anémique
- Fièvre, douleurs osseuses
- Splénomégalie

HEMOGRAMME

GB.....	193.5	4 - 10 G/L
PNN.....	5.95	G/L
Eosino.....	0.3	G/L
Baso.....	0.56	G/L
Lympho.....	171.57	G/L
Mono.....	15.12	0.1 - 1 G/L
PNN%.....	3	
Eosino%.....	0.2	
Baso%.....	0.3	
Lym%.....	88.7	
Mono%.....	7.8	
GR.....	3.53	
HCT.....	25.9	
HGB.....	8.6	g/dL
VGM.....	73.4	80 - 100 fL
TCMH.....	24.4	27 - 32 pg
CCMH.....	33.2	32 - 36 g/dL
PLT.....	38	150 - 400 G/L
VPM.....	---	
IDR.....	---	
IDR-CV.....	15.7	
IDR-DS.....	40.4	

PNN=03%

GJ=01%

LYM=10%

Blastes = 86%

20233475

Observation N°2

- Homme de 66 ans
- Polyadénopathies cervicales et axillaires, bilatérales et symétriques de 1.5 – 2 cm.
- Splénomégalie

Antécédants

Valeurs Usuelles

HEMATOLOGIE

NUMERATION ET FORMULE SANGUINE

HÉMATIES.....	4.43 10 ⁶ /μL	4.29 10 ⁶ /μL 04/06/25	(4.08 - 5.60)
HÉMATOCRITE.....	38.8 %	37.1 % 04/06/25	(38 - 49)
HÉMOGLOBINE.....	12.4 g/dL	12.3 g/dL 04/06/25	(13.4-16.7)
V.G.M.....	87.6 fL	86.5 fL 04/06/25	(80 - 95)
C.C.M.H.....	32.0 g/dL	32.3 g/dL 04/06/25	(30 - 35)
T.C.M.H.....	28.0 pg	28.7 pg 04/06/25	(28 - 32)
RDW.....	14.0 %	14.1 % 04/06/25	(11 - 14)
LEUCOCYTES.....	160330 /mm3	113290 /mm3 04/06/25	(3800 - 10000)

FORMULE LEUCOCYTAIRE

Polynucléaires Neutrophiles.....	8016.50 /mm3	Soit : 5.00 %	(1600 - 5900)
Polynucléaires Eosinophiles.....	1603.30 /mm3	Soit : 1.00 %	(30 - 500)
Polynucléaires Basophiles.....	0.00 /mm3	Soit : 0.00 %	(0 - 100)
Lymphocytes.....	147503. /mm3	Soit : 92.00 %	(1070 - 4100)
	60		
Monocytes.....	3206.60 /mm3	Soit : 2.00 %	(230 - 710)
NUMERATION DES PLAQUETTES.....	253 10 ³ /mm3	333 10 ³ /mm3 04/06/25	(150 - 450)

Interprétation Hyperlymphocytose / Anémie normochrome normocytaire

RETICULOCYTES

RETIC 110750 /mm3

Valeurs usuelles:

< 120 000/mm3: anémie arégénérative

> 120 000/mm3: anémie régénérative

Observation N°3

- Homme de 55 ans
- Céphalées, flou visuel, bourdonnement des oreilles
- Splénomégalie

HEMOGRAMME

GB.....	11.97	4 - 9 10 ³ /μL	9.25 (
Grn#.....	5.48	1.1 - 7 10 ³ /μL	5.8 (
Eos#.....	0.12	<= 0.9 10 ³ /μL	0.04
Bas#.....	0.03	<= 0.2 10 ³ /μL	0.03
Lym#.....	5.41	0.7 - 5.1 10 ³ /μL	2.8
Mon#.....	0.93	<= 0.9 10 ³ /μL	0.58
Grn%.....	45.85	28 - 78 %	62.7
Eos%.....	0.98	<= 10 %	0.3
Bas%.....	0.21	<= 2 %	0.3
Lym%.....	45.18	17 - 57 %	30
Mon%.....	7.78	<= 10 %	6.
GR.....	5.87	3.76 - 5.7 10 ⁶ /μL	5
HCT.....	57.4	33.5 - 52 %	
HGB.....	18.98	12 - 18 g / dL	1
VGM.....	97.8	80 - 100 fL	
TCMH.....	32.3	28 - 32 pg	
CCMH.....	33.1	31 - 35 g /dL	
IDR.....	11.6	11.6 - 14 %	
PLT.....	288.8	150 - 400 10 ³ /μL	

Observation N°4

- Femme de 40 ans
- Céphalée, vertige
- Splénomégalie

HEMOGRAMME

GB.....	13.62	4 - 10 G/L	11.43 (25/03/25)
PNN.....	9.67	G/L	8.82 (25/03/25)
Eosino.....	0.31	G/L	0.17 (25/03/25)
Baso.....	0.09	G/L	0.09 (25/03/25)
Lympho.....	2.92	G/L	1.91 (25/03/25)
Mono.....	0.63	0.1 - 1 G/L	0.44 (25/03/25)
PNN%.....	71		77.2 (25/03/25)
Eosiino%.....	2.3		1.5 (25/03/25)
Baso%.....	0.7		0.8 (25/03/25)
Lym%.....	21.4		16.7 (25/03/25)
Mono%.....	4.6		3.8 (25/03/25)
GR.....	3.92		3.72 (25/03/25)
HCT.....	32.5		30.6 (25/03/25)
HGB.....	10.2	g/dL	9.6 (25/03/25)
VGM.....	82.9	80 - 100 fL	82.3 (25/03/25)
TCMH.....	26	27 - 32 pg	25.8 (25/03/25)
CCMH.....	31.4	32 - 36 g/dL	31.4 (25/03/25)
PLT.....	2072	150 - 400 G/L	1840 (25/03/25)
VPM.....	9.5		9.6 (25/03/25)
IDR.....	10.8		10.5 (25/03/25)
IDR-CV.....	22.3		20.9 (25/03/25)
IDR-DS.....	63.5		58.6 (25/03/25)

Observation N°5

- Homme de 38 ans
- Douleur de l'HCG
- Splénomégalie

HEMATOLOGIE

Valeurs Usuelles

HEMOGRAMME

HEMATIES	3.31 Millions/mm ³	(4.5 - 5.9)
Hémoglobine	9.9 g/dl	(13 - 17)
Hématocrite	30.50 %	(38 - 52)
VGM	92.00 fl	(80 - 110)
TCMH	29.80 pg	(27 - 34)
CCMH	32.30 g/dl	(30 - 36)
RDW	20 %	(11,6% - 14,6%)
LEUCOCYTES	82 490 /mm ³	(4000 - 10000)

FORMULE LEUCOCYTAIRE

Polynucléaires Neutrophiles	85 %	Soit : 70 117 /mm ³	1700 - 7500
Polynucléaires Eosinophiles	1 %	Soit : 825 /mm ³	(<500)
Polynucléaires Basophiles	0 %	Soit : 0 /mm ³	(0 - 100)
Lymphocytes	6 %	Soit : 4 949 /mm ³	(1500 - 4000)
Monocytes	2 %	Soit : 1 650 /mm ³	(100 - 1200)
Granulocytes jeunes	6% soit 4949/mm ³		
PLAQUETTES	480 700 /mm ³		(150 000 - 500 000)

Observation N°6

- Homme de 66 ans
- AEG, syndrome anémique
- Splénomégalie à l'ombilic
- NFS: GB: 10800 (PNN: 7800)
Hb: 6,8 g/dl
Plaquette: 460 G/L
- Myélogramme: moelle pauvre
- BOM: Fibrose médullaire Grade 2

Cas clinique n°1

- Patient âgé de 64 ans qui consulte pour syndrome anémique évoluant depuis 3 mois.
- A l'examen: multiples adénopathies bilatérales et symétriques cervicales et axillaires (2 à 3 cm) avec une splénomégalie à 4 cm du rebord costal.
- NFS: GB=130 000 (Lymphocytes: 72%)
HB=9,3 g/dl (VGM : 85, TCMH: 25),
Rétic : 85 000
PLQ=80.000

- **1- Interprétez l'Hémogramme**

- ▶ Frottis sanguin : lymphocytes matures monomorphes, avec présence d'ombres de Gumprecht.
- **2- Quel est le diagnostic à évoquer et comment le confirmer ?**

- **Le score du Matutes était à 5/5**
- **3- Y a-t-il une indication au traitement ?
pourquoi ?**

- **4- Citer 3 complications de la LLC.**

Cas clinique n°2

Patient âgé de 54 ans, diabétique sous ADO, consulte pour sensation de pesanteur. L'examen a révélé une SMG à 4 cm du rebord costal.

La NFS a montré:

GB 50800 PNN 45000, Hb 13, Plq 215000

Frottis sanguin: PNN 75% (Myélémie), Lymphocytes 16%
blastés 1%

1/ Le diagnostic le plus probable est:

A/ Leucémie aigue

B/ Leucémie myéloïde chronique

C/ Pathologie inflammatoire chronique

D/ Une cause infectieuse vu que le patient est diabétique

2/ Ainsi comment peut-on confirmer notre diagnostic?

A Ponction sternale

B Caryotype constitutionnel

C Biologie moléculaire

D Biopsie ostéo-médullaire

E Caryotype oncologique

3/ Etant donné que le diagnostic positif repose sur l'étude cytogénétique et moléculaire, y a-t-il un intérêt de réaliser un myélogramme?

Notre patient a été mis sous ITK de 1^{ère} génération (IMATINIB) à la dose de 400mg/j en continue.

4/ Comment on va surveiller notre patient?

A/ une NFS

B/ une quantification du taux du transcrit bcr-abl sur sang périphérique tous les 3 mois

C/ une étude cytogénétique tous les 3 mois

D/ l'activité de la tyrosine kinase tous les 3 mois

E/ un myélogramme tous les 3 mois

5/ Sachant que l'objectif à 3 mois est d'avoir un ratio $\text{bcr-abl} < 10\%$, Quelle sera notre conduite si le ratio pour notre patient était 23% à 3 mois?

Le patient était perdu de vue pendant 12 mois et a reconsulté pour une altération de l'état général, un purpura pétéchial diffus avec épistaxis.

6/ Qu'est-ce que vous suspectez?

La NFS a montré GB 124800 Lymphocytes 70000 PNN
48000 Hb 4 VGM 85 Plq 9000 retic 20000
7/ Quelle sera votre conduite immédiate?

A/ demander un frottis sanguin

B/ switcher vers un ITK 2^{ème} génération et contrôler après
1 mois

C/ Hospitaliser le patient en urgence

D/ Pratiquer un myélogramme afin de confirmer la
transformation

E/ Si la transformation se confirme, le patient sera
candidat à une chimiothérapie type LA associée à un ITK
de 2^{ème} génération

Merci pour votre attention

